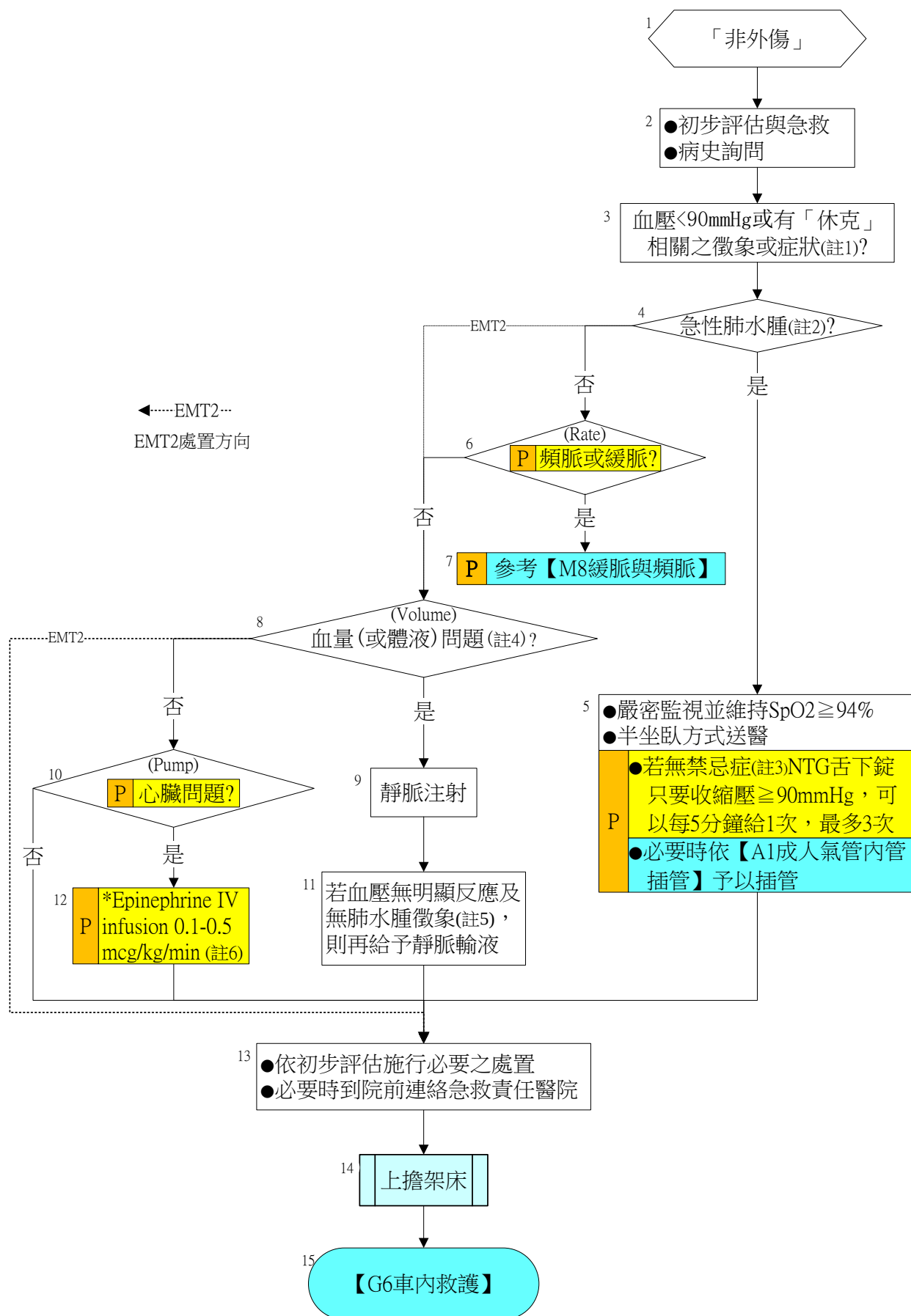




M10 急性肺水腫、低血壓及休克



程 序



要 旨

- 一、休克病人之處理，EMT2之評估與處置，以是否應處理血量或體液（Volume）問題為主，並參考【M3意識改變】及【T6外傷性休克】處置。
- 二、休克病人之處理，EMTP 之評估與處置應以「速率（Rate）、血量或體液（Volume）、幫浦（心臟收縮力）（Pump）」迅速反應，接著經由完整的病史詢問與病人評估，嘗試區分病人之休克可能為心因性、阻塞性、低血容性、敗血性、過敏性或神經性，並參考【M3意識改變】及【T6外傷性休克】處置。

註 解

註1>

「休克」指組織灌流不足的現象，臨床上可以有多種表現，例如：(1) 血壓降低（收縮壓 $< 90\text{mmHg}$ ）、(2) 心跳變快（每分鐘 ≥ 100 下 或 心跳數值 $\geq$ 收縮壓數值）或脈搏變微弱、(3) 呼吸變快或變深（可能有代謝性酸中毒）、(4) 意識混亂或昏沉、(5) 臉色蒼白、皮膚溼冷或出現紫斑、(6) 微血管充填時間（CRT） ≥ 2 秒、(7) 尿量變少…等等。EMT應仔細評估低血壓的病人是否處於休克狀態，以決定現場最適切的治療。

註2>

急性肺水腫：病人呈現明顯呼吸急促（可能有胸痛），且合併咳嗽及帶有血絲的泡沫痰液、端坐呼吸、發紺、頸靜脈怒張、聽診有肺囉音等。

註3>

每5分鐘建議服用1次，到院前最多服用3次，且應持續監測其收縮壓 $\geq 90\text{mmHg}$ 。脈搏小於50或 ≥ 100 次/分時應小心使用、48小時內使用過壯陽藥物之病人不可服用。

註4>

如果判斷沒有血量（或體液）過多的表現，可以予以靜脈注射輸液。血量（或體液）過多的表現，可能包括：端坐呼吸、頸靜脈怒張、聽診有肺囉音、下肢水腫等。

註5>

肺水腫徵象：呼吸淺快、端坐呼吸、頸靜脈怒張、聽診有肺囉音等。

註6>

若收縮壓 $< 70\text{mmHg}$ 且後送時間較長，可經線上醫療指導同意，將1支*Epinephrine加入N/S 500ml（ $=2\text{mcg/ml}$ ），調整點滴數至每秒1滴（此時劑量為 6mcg/min ；即為 0.1